

11 - 01- TUBERCULOSE ABDOMINALE - Pr. Samlani

(0:01 - 0:25)

La tuberculose abdominale La tuberculose abdominale est l'ensemble des manifestations pathologiques liées à la localisation intra-abdominale du bacille de corps. C'est un problème de santé publique et qui a connu une recrudescence de son incidence avec l'avènement de l'épidémie du sida. Cette tuberculose abdominale a une particularité, qu'elle est polymorphe cliniquement et radiologiquement.

(0:26 - 0:38)

Le diagnostic de certitude sera posé par la bactériologie et par dystologie. Le traitement est bon quand il est instauré précocement. Ce sont les antibacillaires que l'on utilise.

(0:40 - 0:57)

La tuberculose abdominale arrive au troisième rang de la localisation extra-pulmonaire. Il peut y avoir une coexistence de tuberculose pulmonaire et abdominale, péritonéale, intestinale ou hépatique. Elle survient en général à tous les âges avec une forte prévalence entre 25 et 45 ans.

(0:57 - 1:19)

Il n'est pas reconnu de sexe ratio, sauf pour les formes péritonéales, où on note une légère prédominance féminine. Les éléments qui influencent la fréquence sont la précarité du niveau d'hygiène et du niveau socio-économique. C'est pour cela que l'Afrique est encore réellement touchée par la tuberculose.

(1:23 - 1:48)

Il a été noté une recrudescence de son incidence dans les pays développés. Plusieurs facteurs ont aidé à cela, notamment le VIH, qui a augmenté la fréquence des formes extra-pulmonaires de plus de 50%. Les thérapies immunosuppressives, le diabète, l'incidence rénale, donc toutes les comorbidités, peuvent présenter un terrain favorable à la tuberculose.

(1:51 - 2:34)

Le bacille responsable est le BK. C'est un bacille acido-alcool-résistant que l'on peut retrouver grâce à la PCR en déroulant son ADN. La transmission peut être inter-humaine par la salive.

Elle peut également être bovine par le lait contaminé. Les voies de cheminement reconnues sont la voie hématogène, qui sera responsable d'atteintes péritonéales, ganglionnaires, digestives, hépatiques et spléniques. C'est la transmission par le sang.

(2:35 - 2:51)

La voie lymphatique, la voie des ganglions. La voie digestive, endogène ou exogène. Endogène, c'est-à-dire la déglutition, donc la salive elle-même, si on déglutit des expectorations.

(2:51 - 3:24)

Ou bien exogène, par des aliments souillés. La continuité, c'est le cas de la tuberculose génitale, quand une tuberculose péritonéale est déjà existante. Ce bassin va provoquer une inflammation excudative non spécifique, qui va utiliser des médiateurs, qui sont l'adénosine des aminases, l'interféron gamma, et qui sont des marqueurs d'immunité cellulaire, et qui vont nous aider pour le diagnostic de la tuberculose.

(3:25 - 3:56)

La recherche de ces marqueurs pourra aider à poser le diagnostic de la tuberculose. Après cette phase d'inflammation, la formation de caséum pourra se faire, elle est inconstante. Ensuite se produira une réaction tissulaire avec une couronne épithéloïde, pour donner le fameux granulome épithéloïde gigantomacrophagocellulaire, avec de la nécrose caséuse, qui est spécifique de la tuberculose, mais qui n'est pas toujours retrouvée.

(3:58 - 4:31)

Et ce granulome peut se caséifier, c'est-à-dire être siège de caséum, et le mot caséum vient de caseo, qui est fromage, parce que c'est une formation blanchâtre pâteuse qui ressemble à du fromage. Il pourra se calcifier, c'est une forme de cicatrisation, ou bien se fistuliser dans d'autres organes. Donc l'évolution du granulome épithéloïde gigantomacrophagocellulaire peut être la caséification, la calcification ou la fistulisation.

(4:33 - 5:17)

Et vous voyez ici le granulome épithéloïde gigantomacrophagocellulaire avec de la nécrose casée. Alors quelle est l'évolution des lésions ? Les lésions qui ne sont pas caséifiées peuvent évoluer vers de la fibrose, c'est-à-dire l'inflammation pourra donner de la fibrose par la suite, et cette fibrose peut être responsable de sténose, de rétrécissement ou bien de synéchies. Et les synéchies sont des formes de cicatrisation qui sera responsable d'une sorte de fusion des membranes, et qui sera responsable bien sûr de sténose.

(5:17 - 6:16)

Les lésions caséifiées pourront soit confluer et former de grosses lésions caséifiées, c'est-à-dire confluer les unes vers les autres, soit se ramollir et éventuellement fistuliser, soit s'entourer d'une coque, et il y aura l'intérieur qui sera caséifié mais l'extérieur qui est une coque, c'est une sorte d'abcès froid, soit s'évacuer, soit carrément s'assécher et se caséifier, c'est une forme de cicatrisation. Je prendrai l'exemple de la tuberculose péritonéale. La forme inflammatoire, c'est la

granulite tuberculeuse, c'est-à-dire que tout le péritoine sera siège de granulite, d'une inflammation, et il y aura une exudation qui sera responsable d'une sécrétion d'un liquide qui sera l'acide.

(6:18 - 6:32)

La nécrose caséeuse sera responsable de la forme uséro-caséeuse. Ce sont des masses caséeuses qui peuvent confluer. Il y aura également de l'acide qui est secondaire à l'exudation.

(6:32 - 7:42)

Il y aura cette forme de cicatrisation, les synéchies qui sont les adhérences, et qui seront responsables du collage des feuillets péritonéaux, et il y aura des agglutinations des ences. L'évolution ultime de tout ça sera ce qu'on appelle la forme fibroadhésive, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de synéchies, que tout le péritoine sera collé, que les ences intestinales seront agglutinées, et ça va évoluer vers ce qu'on appelle la forme encapsulante, qui est une forme historique, qui heureusement on ne la retrouve pas très souvent, où tout le ventre sera donc pris par ces synéchies, par ces adhérences, et il aura une forme de bateau, il sera creusé. Ça c'est l'évolution de la tuberculose péritonéale, sachant qu'on peut faire le diagnostic à chacune des étapes, c'est-à-dire qu'on peut faire le diagnostic à la forme inflammatoire, qui est la granulite tuberculeuse, on peut faire le diagnostic au stade de forme acétique, comme on peut faire le diagnostic au stade de forme uséro-caséeuse, et heureusement pour nous, les formes fibroadhésives et encapsulantes sont de plus en plus rares.

(7:48 - 8:19)

Je prendrai comme diagnostic positif la tuberculose péritonéale dans sa forme acétique isolée. Les circonstances de découverte sont variables, et généralement la symptomatologie est liée à l'acide. On peut retrouver des douleurs abdominales, une distension abdominale, on peut retrouver des signes d'imprégnation tuberculeuse, avec des signes généraux, fébricules, amégrissement, altération de l'état général, améliorée secondaire, et le bilan va s'attacher à la recherche de localisation secondaire.

(8:21 - 9:05)

L'examen clinique va rechercher le tableau d'acide libre, et vous vous rappelez qu'en sémiologie, une acide libre, c'est une acide qui est mobile, qui est déclive, ou bien cloisonnée, on parle alors de matité en davier, avec alternance de zones de matité et de zones qui sont sonores. Il faut toujours s'attacher à rechercher une autre localisation de la tuberculose. Alors quels sont les premiers examens complémentaires que l'on réalise quand on est face à une acide ? Le premier examen que l'on doit faire, quand c'est une acide qui est, rappelez-vous les cours de sémiologie, une acide qui est libre, on pourra commencer par une portion de liquide d'acide.

(9:07 - 9:58)

C'est un liquide qui a des caractéristiques particulières, qui est jaune citrant, qui est riche en protides, avec une prédominance de l'infocyte, et on peut doser dans ce liquide les marqueurs dont je vous ai parlé, l'immunité, l'adénosine des aminases, qui est un marqueur qui est excellent pour la diagnostic de la tuberculose, qui a une valeur prédictive négative de l'ordre de 98%, c'est-à-dire que si elle est négative, on peut dire à 98% des cas que ce n'est pas une tuberculose, et on peut doser également l'interféron gamma, qui a aussi une bonne sensibilité-spécificité, mais qui est un petit peu plus coûte. Comme on fait ce prélèvement de liquide d'acide, l'isolement du BK pourra être réalisé. Sur l'examen direct, il faut savoir qu'on a une chance d'avoir du BK dans moins de 10% des cas.

(9:58 - 10:24)

Ce qu'il faut vous rappeler, c'est que le liquide d'acide tuberculose est un liquide qui est possible acilaire. On peut essayer de faire une culture, mais elle est tardive de 3 à 4 semaines. La PCR permet une détection dans les 24-48 heures de l'ADN de notre bacille, avec une sensibilité qui est de l'ordre de 60 à 80% des cas, avec des risques de faux négatifs qui n'est pas négligeable.

(10:28 - 10:58)

Donc, si l'acide est libre dans la qualité péritonéale, on peut faire la ponction d'acide d'emblée. Mais il est préférable si on a, bien sûr, une acide qu'on suspecte être secondaire à une tuberculose, une acide qui est cloisonnée, ou surtout chez une femme où les diagnostics différentiels, rappelez-vous, sont la grossesse, sont les kystes de l'ovaire, sont une hydronephrose. Il faut réaliser une échographie abdominale avant.

(10:59 - 11:25)

Elle a l'intérêt de voir les sites, de voir les adhérences, les enceintes glutinées, les granulations, rechercher un épaississement péritonéal d'adénopathie profonde. La TDM n'apportera pas grand chose par rapport à l'échographie, mais une radio de thorax peut rechercher des localisations pulmonaires de tuberculose, notamment des cavernes humilières. Un bilan biologique peut être utile.

(11:26 - 11:41)

Pourquoi ? Parce qu'il permettra, sur toute numération formule sanguine, de rechercher une anémie, une leucopénie, une lymphopénie. Une vesse va être accélérée. Et c'est surtout la recherche de béquins dans les autres liquides biologiques qui peut aider aux diagnostics positifs.

(11:41 - 12:06)

On peut demander l'interféron gamin, mais la particularité de l'interféron gamin, c'est qu'il sera

également positif quand c'est une maladie qui est latente. Donc, il ne fera pas la différence entre tuberculose latente et maladie. L'intradermoréaction que l'on réalisait et qui était donc auparavant systématiquement réalisée à la tuberculine a une faible sensibilité, une faible spécificité.

(12:12 - 12:38)

Un autre examen qui est important, c'est la celluloscopie exploratrice. Bien sûr, qui a supplanté la laparotomie exploratrice. La celluloscopie pourra se faire par les voies naturelles et qui va rechercher des signes au niveau du péritoine, la présence d'une hyperémie, c'est-à-dire d'une rougeur du péritoine, de granulation blanchâtre translucide, de signes d'inflammation péritonéale d'adhérence, de nodules jaunâtres.

(12:39 - 13:09)

Elle permettra bien sûr de faire des biopsies, c'est surtout ça l'objectif, à la recherche du fameux granulome épithélio-gigantocellulaire avec nécrose caséeuse. Je vous montre ici l'aspect du péritoine et vous pouvez voir les synéchies ou bien les adhérences avec les petites lésions qu'on voit qui sont translucides, qui sont en tête d'épingle et qui sont caractéristiques de tuberculose. Certains examens sont impératifs.

(13:09 - 13:35)

Une radiographie de thorax, la recherche de barres sur produits d'expectoration ou bien un prélèvement lors d'une fibroscopie bronchique si la radiographie de thorax est anormale avec un prélèvement négatif, la sérologie HIV. Je vous rappelle qu'on parle d'acidose tuberculeuse et dans ce cas la diagnose différentielle sera toutes les acidoses. C'est une acidose qui est riche en protéines, donc on va penser en premier lieu à l'acidose néoplasique, c'est le principal diagnostic différentiel.

(13:36 - 13:53)

Généralement, c'est des sujets qui sont un petit peu plus âgés, ça ne veut pas dire grand-chose. Le liquide peut être hémorragique au lieu d'être jaune citron et on peut rechercher dans le liquide de l'acidose néoplasique les cellules malignes. La laparotomie et la celluloscopie pourront poser le diagnostic également.

(13:54 - 14:11)

Deuxième diagnostic différentiel, c'est l'acidose cardiaque. Et là, c'est le tableau clinique, c'est l'échographie Doppler avec dilatation des veines hépatiques de la veine cave inférieure qui pourront poser le diagnostic. Autre type d'acidose, vous vous en rappelez, c'est l'acidose pancréatique.

(14:12 - 14:28)

Et dans ce cas-là, c'est des tableaux qui sont très évocateurs dans le cadre de pancréatite chronique avec rupture de pseudocyste. On pourra également voir la lipase dans le liquide d'acide. Et enfin, l'acide du cirrhotique, qui est un acide qui est pauvre en protides et qui est dans un contexte particulier.

(14:30 - 14:51)

Donc après avoir traité cette forme acidique, nous pourrions parler d'autres formes cliniques de tuberculose péritonéale. Rappelez-vous, la forme aiguë qui est inflammatoire, c'est la granulie. Celle-ci, elle prédomine chez l'enfant et l'adulte jeune avec des signes péritonéaux qui sont très importants, qui peuvent simuler une urgence chirurgicale avec carrément un tableau de péritonite, un tableau d'occlusion fébrile.

(14:52 - 15:07)

La forme subaiguë, anacétique, l'acide absente. Dans ce cas-là, avec une atterrasse de l'état général, les douleurs diffusent. Pour les autres formes chroniques, on a la forme ulcéro-caseuse.

(15:07 - 15:34)

Rappelez-vous que là, on avait beaucoup de caséum et ce caséum, il va prendre l'aspect du gâteau péritonéo et il va donner donc un aspect qui est élastique à l'abdomen. La forme fibro-adhésive qui est secondaire à une forme acidique, on aura un abdomen qui est rétracté en bateau. Et enfin, la forme encapsulante qui est la forme ultime où toutes les anses seront engainées, où l'abdomen sera rétracté.

(15:37 - 15:51)

À part pour la forme péritonéale, il faut savoir que la tuberculose abdominale peut toucher les autres organes. Et c'est pour ça qu'il est important de parler des autres formes topographiques. L'atteinte intestinale grélique ou ileosécale peut exister.

(15:51 - 16:03)

Alors l'atteinte intestinale, il faut savoir que c'est la plus fréquente après l'atteinte péritonéale. Et c'est 80% de localisation intestinale. Trois formes peuvent coexister.

(16:04 - 16:17)

La forme ulcérée qui est la plus fréquente où il y aura une ulcération de l'intestin. La forme hypertrophique qui va se manifester par des bourgeons. Et la forme ulcéro-hypertrophique.

(16:18 - 16:42)

Comme ce sont des localisations au niveau de l'intestin, il peut y avoir une douleur de la fossiliac

droite au péri-ombilical. Pourquoi ? Parce que c'est un syndrome d'obstruction intestinale qui va se manifester parce qu'on connaît, sous le nom de syndrome de Koenig, avec parfois des diarrhées liquidiennes, voire même pour les formes étendues, un syndrome de malabsorption. On peut retrouver une masse ou un empatement de la fossiliaire droite.

(16:43 - 17:04)

Et l'échographie va rechercher un épaississement intestinal, des adénopathies. On pourra tenter de faire des opacifications, notamment des transits du Graal, ou quand on suspecte une forme colique, des coloscopies. Et vous voyez ici, à gauche, une forme ileosécale de la tuberculose avec une sténose que vous voyez très bien.

(17:04 - 17:37)

À droite, ce qu'on a, c'est une échographie qui a montré un épaississement ileosécale. Pour ce qui est de la tuberculose colique extracécale, on peut avoir des tuberculoses carrément coliques ou des tuberculoses rectales qui vont se manifester par des diarrhées ou par une douleur abdominale. L'opacification va retrouver un aspect de sténose qu'on voit ici à gauche et qui peut simuler un cancer.

(17:37 - 18:02)

Et c'est la coloscopie avec biopsie qui pourra poser le diagnostic. Et ce que vous voyez ici, c'est une image réelle de notre service où on avait une suspicion de cancer du sécum et la coloscopie a retrouvé un aspect bourgeonnant avec ce que vous voyez en blanc, qui est le caséum, qui est pathognomonique. Et les biopsies ont retrouvé un granulome épithélio-logique antocellulaire et le patient est traité comme tuberculose.

(18:05 - 18:18)

Enfin, une autre forme de localisation, c'est la tuberculose anopérinéale. La tuberculose anopérinéale peut se manifester par des ulcérations anales. Et on va voir ça quand on va parler de la fissure anale.

(18:18 - 18:37)

La particularité de la tuberculose, c'est qu'il y aura un aspect de fissure qui est différent des fissures normales. On peut avoir également des fistules anales. Les biopsies vont confirmer le diagnostic et le traitement sera particulier parce qu'il va reposer et sur la chirurgie et sur les antiméculaires.

(18:37 - 18:48)

Et là aussi, c'est une image du service. On a une tuberculose anale responsable d'un périnée

polyfistuleux. Autre forme clinique, la forme splénique.

(18:49 - 19:04)

La forme splénique souvent s'accompagne ou accompagne milliards de tuberculoses. Elle peut être latente, comme elle peut avoir un tableau de splénomégalie fébrile associée à une altération de l'état général. Il faut toujours rechercher les autres atteintes.

(19:04 - 19:33)

L'imagerie va rechercher les calcifications des lésions focales et parfois, dans les formes isolées pseudo-tumorales, c'est une splénectomie qui pourra poser le diagnostic. Et vous voyez ici, à gauche, une énorme splénomégalie avec des masses sous-capsulaires et c'est la pièce de splénectomie qui a posé à droite le diagnostic de tuberculose. Autre type de tuberculose abdominale, la tuberculose hépatique.

(19:33 - 19:48)

La tuberculose hépatique est rarement seule isolée primitive. Elle peut être asymptomatique le plus souvent mais n'est jamais responsable d'insuffisance hépatocellulaire ni d'hypertension portale. L'imagerie ne sera pas spécifique et c'est la biopsie du foie qui pourra poser le diagnostic.

(19:49 - 20:06)

Ce que vous voyez ici, c'est une atteinte splénique et hépatique dans le cadre d'une tuberculose et c'est les biopsies qui ont posé le diagnostic. Ceci est un scanner abdominal. Enfin, d'autres formes tuberculeuses dont on parlera rapidement.

(20:06 - 20:24)

La tuberculose peut toucher le pancréas et ça peut mimer un cancer du pancréas. Elle peut toucher le duodenum, l'estomac, la vésicule biliaire. Donc, la tuberculose abdominale peut toucher tous les organes de l'abdomen et surtout quand il y a une miliaire d'atteinte péritoneale, tous les organes peuvent toucher par continuité.

(20:26 - 21:25)

Alors, quelle est l'évolution et le pronostic ? En principe, les complications quand la maladie n'est pas traitée seront l'occlusion, surtout quand il y a une tuberculose intestinale ou même colique, la perforation dans le cas où il y a des ulcérations du petit intestin, des fistules entre différents parties de l'intestin, une fibrose rétropéritoneale, une sténose de l'urètre parce qu'il y aura de la fibrose autour de l'urètre, ça sera responsable éventuellement d'hydronéphrose et la mortalité est très importante pour ces formes négligées. Le traitement, c'est un traitement qui est important,

dont les objectifs seront l'éradication du bécen, la stérilisation des foyers tuberculeux mais qui a un volet aussi épidémiologique parce qu'il faut faire le dépistage familial, prévenir les rechutes et surveiller le patient et sa famille. Le traitement est à base d'antituberculeux, c'est un traitement codifié entre 6 à 9 mois.

(21:26 - 21:53)

Il y aura un traitement d'attaque par une quadritérapie suivie d'une bithérapie. 4% de la population va présenter des résistances et il faudra faire attention aux patients chirotiques chez lesquels on ne pourra pas donner de pyrazinamide et chez lesquels il faudra adapter l'isoniazide et la rifampicine. Le traitement chirurgical est réservé pour les formes compliquées comme par exemple la tuberculose intestinale perforée, la tuberculose colique.

(21:54 - 22:22)

Il faut faire attention il faut mettre un intérêt à traiter les comorbidités et les maladies associées, améliorer l'état d'immunité du patient et bien sûr traiter également les symptômes par les traitements symptomatiques. La surveillance reposera sur la surveillance de l'observance avec adaptation des doses en fonction du poids. L'efficacité bien sûr sera jugée sur la clinique, sur la radiologie et sur la biologie.

(22:23 - 23:03)

Il faudra aussi faire attention à la tolérance. Les antibacillaires ont des effets secondaires et bien sûr aux effets de ces antibacillaires sur les organes, notamment la toxicité hépatique qu'on surveillera par le dosage des transaminases. La prévention de la tuberculose repose bien sûr sur l'amélioration de la qualité de vie, l'hygiène de vie, sur l'information, l'éducation, la communication, sur le dépistage des foyers de contagion et bien sûr sur la vaccination par le BCG qui est obligatoire entre pays.

(23:04 - 23:16)

En conclusion, c'est un problème de santé publique dans notre pays. La localisation peritoneale est encore prédominante. De nombreuses méthodes diagnostiques nous aident à poser ce diagnostic.

(23:17 - 23:37)

Il faut faire la part des choses avec certains diagnostics différentiels, surtout pour la forme peritoneale. Ceux de la site que vous connaissez bien. L'histologie est vraiment l'examen qui pose le diagnostic avec certitude avec l'isolement du BK, du bacille de corps.

(23:37 - 23:47)

C'est une maladie qui est encore fréquente chez nous. Il faut dépister précocement, traiter précocement pour éviter des complications et bien sûr il faut insister sur la prévention.